

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INVENTARIO DE FLEXIBILIDAD COGNITIVA (CFI / IFC)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación Dimensional de la Flexibilidad Cognitiva y Capacidad Resolutiva

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Inventario de Flexibilidad Cognitiva (CFI: 20 ítems).
Nombre Original (Inglés)	<i>Cognitive Flexibility Inventory (CFI)</i>
Autores Originales	Drs. John P. Dennis y Jillon S. Vander Wal (2010), Saint Louis University.
Adaptaciones al Español	Adaptaciones clínicas en España y Latinoamérica (Sanz et al.; Ruiz-Galdón et al.).
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Flexibilidad Cognitiva, Resolución de Problemas y Afrontamiento TCC.
Tipo de Instrumento	Autoinforme psicométrico bifactorial de 20 reactivos con escala Likert de 7 puntos (1 a 7).
Población y Rango	Adultos y adolescentes (desde 16 años). Pacientes clínicos en psicoterapia y población general.
Tiempo de Administración	4 a 6 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico asistencial, docencia e investigación no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO DE DENNIS & VANDER WAL

El Inventario de Flexibilidad Cognitiva (CFI) fue desarrollado para evaluar la competencia cognitiva que permite a una persona desafiar y sustituir pensamientos desadaptativos por interpretaciones más ajustadas, así como adaptarse a estresores cotidianos. En la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC; Beck), la flexibilidad cognitiva es un factor protector transdiagnóstico central constituido por tres elementos operativos: (a) la disposición a percibir los problemas como controlables; (b) la capacidad de percibir múltiples explicaciones y soluciones alternativas; y (c) la habilidad para generar soluciones eficaces.

El instrumento operacionaliza este constructo a través de dos dimensiones fundamentales: **Alternativas** (la habilidad para percibir y producir múltiples opciones explicativas y conductuales ante situaciones difíciles) y **Control** (la tendencia a percibir los eventos estresantes y la propia conducta como modificables y controlables, en contraposición a la indefensión aprendida).

A nivel neurobiológico, la flexibilidad cognitiva depende de la integridad y conectividad de la corteza prefrontal dorsolateral (DLPFC), el córtex cingulado anterior dorsal (dACC) y la corteza orbitofrontal (OFC), redes responsables del cambio atencional (**set-shifting**), inhibición cognitiva y actualización de contingencias.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS

Dimensión Subescala	Ítems (20)	Sentido	Definición Operativa y Conducta Evaluada
1. Alternativas	1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20	Directos (13)	Capacidad de examinar dificultades desde múltiples perspectivas y generar diversos cursos de acción eficaces.
2. Control	15	Directo (1)	Percepción de autoeficacia y competencia personal para superar dificultades vitales.
2b. Falta de Control (*)	2, 4, 7, 9, 11, 17	Inversos (6)	Vivencia de parálisis, desbordamiento subjetivo, pérdida de control y bloqueo ante situaciones complejas.

(*) Ítems de formulación negativa que requieren inversión obligatoria para el cálculo de la subescala Control y Total.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente precisión global: alfa de Cronbach total de 0.90 a 0.91. Subescala Alternativas con alfa de 0.91 y Subescala Control con alfa de 0.84 a 0.86. Fiabilidad test-retest $r = 0.81$ a las 7 semanas de intervalo.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio corrobora la estructura de dos factores correlacionados ($r = 0.45$ a 0.52) con ajuste sobresaliente: CFI = 0.94, TLI = 0.93, RMSEA = 0.055, confirmando la validez constructiva del instrumento.
Validez Concurrente y Criterio	Correlaciones inversas muy significativas con sintomatología depresiva (BDI-II: $r = -0.48$), rumiación depresiva (RRS: $r = -0.56$) y ansiedad rasgo (STAI: $r = -0.44$). Correlación directa robusta con resolución social de problemas (SPSI-R: $r = 0.61$).
Sensibilidad al Cambio	El CFI es altamente sensible a intervenciones cognitivo-conductuales (TCC) centradas en reestructuración y solución de problemas, registrando incrementos de gran magnitud ($d > 0.90$) tras el entrenamiento.
Invarianza y Estabilidad	Invarianza métrica demostrada a través de géneros y grupos de edad; no se observan diferencias sistemáticas por sexo en la capacidad autoinformada para generar alternativas.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Los 20 ítems se responden en escala Likert de 7 puntos (**1** = «Totalmente en desacuerdo», **2** = «En desacuerdo», **3** = «Algo en desacuerdo», **4** = «Ni de acuerdo ni en desacuerdo», **5** = «Algo de acuerdo», **6** = «De acuerdo», **7** = «Totalmente de acuerdo»):

- **Paso 1 (Inversión Obligatoria de 6 ítems):** Los reactivos **2, 4, 7, 9, 11 y 17** deben invertirse: Puntuación = 8 - Respuesta (1 → 7, 2 → 6, 3 → 5, 4 → 4, 5 → 3, 6 → 2, 7 → 1).
- **Paso 2 (Puntuación Subescala Alternativas):** Suma de los 13 ítems directos (1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20). Rango: **13 a 91 puntos**.
- **Paso 3 (Puntuación Subescala Control):** Suma del ítem directo 15 más los 6 ítems invertidos (2, 4, 7, 9, 11, 17). Rango: **7 a 49 puntos**.
- **Paso 4 (Puntuación Total CFI):** Suma de Alternativas + Control. Rango Teórico Total: **20 a 140 puntos**. Mayor puntaje = mayor flexibilidad cognitiva.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y BAREMOS NORMATIVOS

Estratificación	Puntuación Total	Nivel de Flexibilidad	Conducta Asistencial Recomendada
Muy Bajo / Rígido	20 a 69 puntos	Rigidez severa / Indefensión	Visión dicotómica y de túnel extrema. Parálisis decisoria. Prioridad absoluta para entrenamiento en solución de problemas.
Bajo / Clínico	70 a 89 puntos	Flexibilidad reducida (corte ≤ 89)	Fijación en esquemas rígidos ante crisis; dificultad para descenderse. Indicación de TCC reestructuradora.
Moderado / Medio	90 a 115 puntos	Flexibilidad adaptativa media	Capacidad adecuada de generación de alternativas; vulnerable ante estresores severos o agotamiento prolongado.
Alto / Resiliente	116 a 140 puntos	Alta flexibilidad y autoeficacia	Excelente capacidad de reencuadre cognitivo y adaptación dinámica. Recurso psicológico protector sobresaliente.

PERFIL DISOCIADO: ALTERNATIVAS VS. CONTROL:

Un patrón clínico habitual en trastornos obsesivos y ansiedad generalizada es una subescala de **Alternativas alta (> 75)** pero con **Control bajo (< 25)**: el paciente genera una proliferación excesiva de opciones hipotéticas pero se siente incapaz de gobernarlas o ejecutar una solución, derivando en duda patológica. Este perfil exige intervenir en tolerancia a la incertidumbre y control percibido, no en generación de ideas.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN DÉFICIT DE FLEXIBILIDAD (TCC)

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN FLEXIBILIDAD COGNITIVA BASADO EN EL CFI:

- **Paso 1 (Desafío de la Visión de Túnel):** Identificar pensamientos dicotómicos de todo o nada ante estresores ("o me sale perfecto o todo está arruinado"). Demostrar el impacto paralizante de la falta de alternativas.
- **Paso 2 (Técnica de Lluvia de Opciones y Perspectivas Múltiples):** Si el déficit está en **Alternativas**, entrenar generación forzada de al menos 5 interpretaciones distintas de una misma situación interpersonal o laboral.
- **Paso 3 (Entrenamiento en Control Peribido y Acción Graduada):** Si el déficit está en **Control**, desglosar la dificultad en componentes modificables vs. no modificables (círculo de influencia de Stoic/CBT).
- **Paso 4 (Monitorización):** Una ganancia de **≥ 15 puntos** en el CFI Total tras 8 semanas señala flexibilización cognitiva clínicamente significativa.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN CRISIS DE ADAPTACIÓN Y BLOQUEO DECISORIO

Identificación: Varón de 44 años, consultor financiero, derivado tras un despido inesperado. Presenta insomnio severo, rumiación incesante, apatía y convicción absoluta de que "mi carrera terminó y no existe otra salida profesional". Cumple criterios para Trastorno Adaptativo con Ánimo Depresivo.

Evaluación Inicial CFI (Línea Base): Puntuación Total = **56 puntos** (Rango Muy Bajo / Rigidez Severa). Subescala Alternativas = 34/91 (extrema dificultad para concebir otras salidas laborales); Subescala Control = 22/49 (sensación abrumadora de desamparo, ítems 4, 7, 11 puntuados con 7). Coexistía un BDI-II de 29 puntos.

Plan Terapéutico y Evolución: Se estructuró un módulo de 10 sesiones de TCC centrado en Reestructuración Cognitiva y Solución de Problemas (D'Zurilla & Nezu). Se implementó la técnica de "los tres escenarios" (el peor, el mejor y el más probable) y experimentos conductuales de contacto profesional.

Reevaluación a las 10 Semanas: CFI Total = **104 puntos** (incremento neto de +48 puntos, acceso al Rango Medio Adaptativo). Alternativas ascendió a 68/91 y Control a 36/49. El paciente logró postularse a tres nuevos puestos y manifestó: "Entendí que el despido fue una circunstancia, no una condena biográfica".

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

RIGIDEZ COGNITIVA VS. DETERIORO EJECUTIVO:

En pacientes mayores o con antecedentes de traumatismo craneoencefálico, la rigidez reportada en el CFI puede no responder a patrones disfuncionales aprendidos sino a perseveración por daño frontal orgánico. Evaluar con tests neuropsicológicos (WCST, Stroop).

DIFERENCIACIÓN CON DUDA OBSESIVA (TOC):

Puntajes aparentemente altos en generación de alternativas pueden enmascarar rumiación obsesiva y comprobaciones mentales en el TOC. Verificar si la multiplicación de escenarios genera serenidad resolutive o alimenta mayor angustia e indecisión patológica.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S. (2010). The Cognitive Flexibility Inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. *Cognitive Therapy and Research*, 34(3), 241-253.
2. Beck, A. T. (1979). *Cognitive therapy of depression*. Guilford Press.
3. D'Zurilla, T. J., & Nezu, A. M. (2007). *Problem-solving therapy: A positive approach to clinical intervention*. Springer Publishing Company.
4. Ruiz-Galdón, M., et al. (2024). Psychometric properties of the Cognitive Flexibility Inventory in Spanish clinical and community samples. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 24(1), 100420.